

MODULE ÉVALUATION

Ce qu'il faut retenir

Aide-mémoire du volet en ligne

Chaque leçon du module en ligne est ramenée à ses quatre ou cinq idées essentielles. Ce document ne remplace ni le manuel, ni les capsules, ni la pratique en classe. Il vous sert de point de repère avant le volet en présentiel et de rappel rapide après la formation.

Le SEP est le fil conducteur de toute la formation. Il sera réutilisé dans chaque chapitre suivant et dans chaque scénario en classe. Imprimez la fiche SEP et gardez-en une copie dans votre trousse.

CONTENU DU MODULE — SEPT LEÇONS

00 Introduction au chapitre

ÉVALUER

01 Système d'évaluation du patient (SEP)

02 Triage

03 État de choc

AGIR ET ÉVACUER

04 Déplacement des victimes

05 Considérations liées à l'évacuation

06 Communication

00

Introduction au chapitre

Six leçons pour évaluer une victime, décider, et organiser la suite

Pourquoi ce chapitre : en région isolée, personne ne prendra la relève dans les prochaines minutes. Votre évaluation doit être complète, ordonnée et écrite, parce que c'est vous qui déciderez de la suite.

- 1 Deux temps : évaluer, puis agir et évacuer.** Les trois premières leçons construisent le jugement clinique (SEP, triage, état de choc). Les trois suivantes organisent la réponse (déplacement, évacuation, communication).
- 2 Le SEP est votre repère du début à la fin.** Même séquence pour un malaise et pour un traumatisme, pour une victime et pour dix. Elle vous évite d'oublier une étape sous pression.
- 3 Les signes vitaux en série remplacent le laboratoire.** Sans imagerie ni analyses, c'est l'évolution des signes vitaux dans le temps qui vous dit si la victime se stabilise ou se détériore. Le choc se reconnaît ainsi.
- 4 Décider, c'est aussi savoir attendre.** Évacuer de nuit, en tempête, avec un groupe épuisé peut créer une deuxième victime. La leçon 05 vous donne les critères pour trancher.
- 5 En ligne le raisonnement, en classe les gestes.** Examen physique, retournement, BEAM, enveloppe isothermique et scénarios complets se pratiquent en présentiel, fiche SEP en main.

01

Système d'évaluation du patient (SEP)

Le SEP, votre repère du début à la fin de la formation

Une séquence fixe, toujours dans le même ordre. La pyramide vous rappelle que la base doit être solide avant de monter.

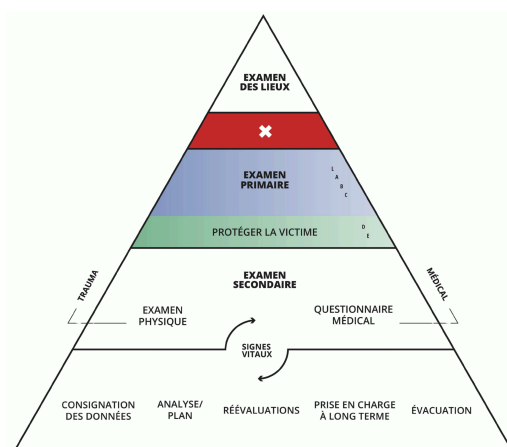


Figure 1 — La pyramide SEP : chaque étage suppose le précédent complété.

- 1 **L'examen des lieux, avant de toucher la victime.** Ma sécurité et celle du groupe, mécanisme de blessure ou nature du problème, nombre de victimes et de témoins, précautions universelles, ressources et demande d'aide. Ce que vous observez sur place (hauteur de chute, position) est une donnée objective : notez-la.
- 2 **L'examen primaire, ce qui tue en quelques minutes.** Hémorragie extrême à contrôler d'abord, puis voies respiratoires, respiration, circulation, état neurologique (AVDI) et exposition. Vous traitez au fur et à mesure : une menace vitale trouvée est une menace vitale corrigée avant de continuer.
- 3 **Protéger la victime avant l'examen secondaire.** Chaleur, isolation du sol, abri, position. En région isolée, l'environnement devient un problème médical si vous l'oubliez.
- 4 **L'examen secondaire, trois séries d'informations.** Signes vitaux (conscience, respiration, pouls, peau, tension, pupilles, température), examen physique de la tête aux pieds, questionnaire SAMPLE. Blessé : l'examen physique d'abord. Malade : le questionnaire d'abord. Signes observés, symptômes rapportés.
- 5 **Consigner sur la fiche SEP et réévaluer.** Subjectif, objectif, analyse (liste des problèmes), planification (un plan par problème). Signes vitaux repris à intervalles réguliers, par la même personne : c'est la tendance qui compte.

02

Triage

Plusieurs victimes, des ressources limitées

Le triage classe les victimes avant de les traiter. Vous ne soignez pas la première victime rencontrée, mais celle dont la survie dépend le plus de vos prochaines minutes.

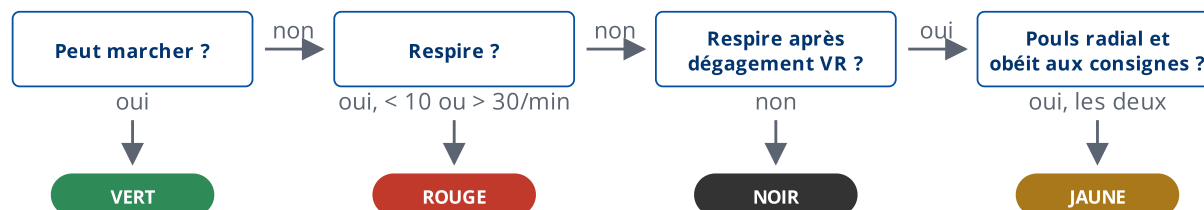


Figure 2 — Algorithme START simplifié (manuel terrain, page 59). Toute autre réponse à la dernière question (pas de pouls radial, retour capillaire de plus de 2 s) : rouge. Les couleurs attribuées peuvent changer : surveillez constamment l'ABC et réévaluez.

- 1 Quatre couleurs, quatre priorités.** Rouge : soins immédiats, fonctions vitales atteintes. Jaune : soins différés, état grave mais peut attendre un court moment. Vert : blessures mineures, souvent capable de marcher. Noir : décédée ou irrécupérable avec les moyens disponibles.
- 2 La méthode START, trois critères.** Respiration, circulation, état de conscience. Rapide et simple, elle vous amène presque immédiatement auprès des victimes les plus critiques.
- 3 Première étape : dégager le site.** Demandez à tous ceux qui peuvent marcher de se rendre à un point désigné. Ils sont provisoirement verts et seront réévalués plus tard. Il ne reste sur les lieux que les victimes qui ne peuvent pas bouger.
- 4 Une décision difficile mais nécessaire.** En présence de victimes multiples, une victime qui ne respire pas après dégagement des voies respiratoires est classée noire. Le temps d'une RCR est du temps retiré aux victimes qui peuvent être sauvées.
- 5 Étiqueter, réévaluer, déléguer.** Improvisez des étiquettes avec ce que vous avez. L'état des victimes change vite : réévaluez toutes les couleurs, y compris les verts. Les blessés légers peuvent surveiller une respiration ou aider à porter.

03

État de choc

Reconnaître l'évolution d'une blessure ou d'une maladie grave

Le choc est une perfusion inadéquate des tissus : l'apport de sang oxygéné aux cellules ne suffit plus. Non reconnu à temps, il mène à la mort. En région isolée, ses causes les plus fréquentes sont l'hémorragie, la déshydratation et l'altitude.

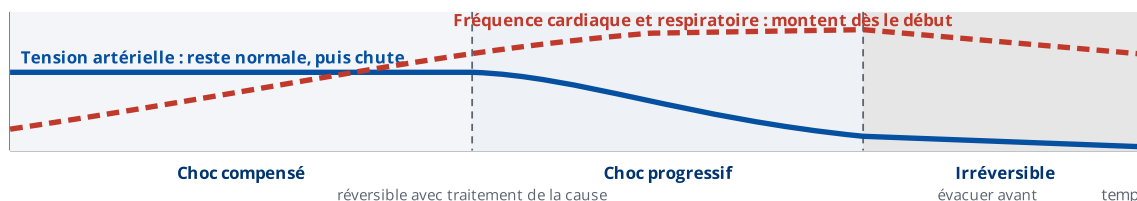


Figure 3 — Une tension normale ne rassure pas : c'est l'accélération du pouls et de la respiration qui signe le choc compensé.

- 1 Quatre grandes familles.** Hypovolémique (hémorragie, déshydratation, brûlures), cardiogénique (le cœur ne pompe plus assez), distributif ou vasodilatatoire (anaphylactique, neurogénique, septique, psychogénique) et obstructif ou respiratoire (l'oxygène n'arrive plus au sang).
- 2 Le choc compensé se cache derrière une tension normale.** Respiration et pouls accélèrent, la peau devient pâle, froide et moite, le remplissage capillaire s'allonge, nausée et anxiété apparaissent. Phase réversible, révélée seulement par des signes vitaux en série.
- 3 Le choc progressif, puis irréversible.** Quand la tension chute, un cercle vicieux s'installe et le choc s'auto-entretient. À ce stade, la seule réponse est l'évacuation la plus rapide possible. L'enfant compense longtemps (jusqu'à 40 % du volume sanguin perdu) puis s'effondre brutalement.
- 4 La prise en charge commence par la cause.** Contrôlez l'hémorragie, ouvrez les voies respiratoires, traitez l'anaphylaxie. Puis : position couchée (Fowler si difficulté respiratoire, latérale de sécurité si inconscient qui respire), chaleur, calme, immobilisation des fractures, surveillance constante des signes vitaux.
- 5 Rien par la bouche au départ, sauf évacuation prolongée.** La victime peut vomir. Si l'évacuation s'étire et qu'elle est consciente et alerte, offrez de petites quantités d'eau et de nourriture. La réaction de stress aigu imite les premiers signes du choc, chez la victime comme chez le secouriste.

04

Déplacement des victimes

Certains déplacements sont urgents, d'autres attendent l'évacuation

Deux moments pour déplacer une victime. Très tôt, si un danger imminent menace la victime ou les secouristes. Beaucoup plus tard, une fois la victime évaluée, traitée et protégée, pour l'évacuer.

- 1 Le danger imminent justifie de déplacer avant d'évaluer.** Avalanche, montée des eaux, feu, chute de pierres, gaz, véhicule instable. Dans ce cas seulement, le déplacement précède l'examen primaire. Sinon, une victime traumatisée n'est pas bougée avant que la colonne ait été considérée.
- 2 Le BEAM : lever et déplacer en bloc.** La victime est déplacée dans la position où elle a été trouvée, tête et tronc alignés, par une équipe coordonnée. Un seul leader donne les consignes et le signal. Pratiqué en classe.
- 3 Choisir la technique selon trois critères.** L'état de la victime (peut-elle marcher, aider, supporter une position), le nombre et la forme des porteurs, le terrain et la distance. Transport à un secouriste, à deux, avec sac à dos, rouleau de corde ou chaise improvisée pour les courtes distances.
- 4 La civière improvisée est longue à fabriquer.** Toile, vestes, sacs à dos à armature, perches. Entraînez-vous d'avance à au moins une méthode adaptée à votre équipement et à votre milieu, plutôt que d'improviser sur place.
- 5 Le transport est une phase de soins, pas une pause.** Comptez un demi-kilomètre à l'heure ou moins en civière. Prévoyez des rotations de porteurs, protégez la victime des intempéries et gardez un accès aux blessures et aux signes vitaux pour réévaluer en route.

05

Considérations liées à l'évacuation

Décider quand, comment, et avec quelles ressources

La décision d'évacuer découle de la fiche SEP : la liste des problèmes dit si l'évacuation est urgente, semi-urgente ou si la victime peut rester avec le groupe. Le reste est une question de logistique et de sécurité.

- 1 Huit éléments à passer en revue, chaque fois.** L'état des victimes et du groupe, l'endroit, les ressources physiques, le type d'assistance requis, le type d'assistance disponible, la météo, le moment de la journée, puis les messagers et les messages écrits.
- 2 Les questions concrètes sur la victime.** Peut-elle marcher ? Faut-il des précautions spinales ? Un membre en attelle ? Quel lieu atteindre et combien de temps pour s'y rendre ? Peut-elle attendre au matin ?
- 3 Le groupe fait partie de l'équation.** Qui porte, qui reste, qui est responsable de ceux qui restent si le leader part ? Un groupe épuisé, mouillé ou effrayé peut produire une deuxième victime. Attendre des conditions optimales est parfois la meilleure décision.
- 4 Les messagers, jamais seuls.** Au moins deux, idéalement quatre, chacun équipé pour passer une nuit dehors et porteur d'une copie du même message écrit.
- 5 Le message écrit dit tout ce que vous ne pourrez pas redire.** Une fiche SEP par victime avec les soins déjà donnés, date, heure et lieu exacts, besoins en matériel et en personnel, noms des personnes restées sur place, fournitures et leur durée, vos plans, le point de rencontre, une aire d'atterrissage ou d'accès motorisé, et toute autre option d'évacuation.

06

Communication

Une méthode adaptée aux premiers soins en régions isolées

Communiquer, c'est transmettre l'essentiel sans ambiguïté à quelqu'un qui n'est pas sur place, souvent par un canal limité (satellite, radio, messenger), pour obtenir la bonne aide, au bon endroit, dans le bon délai.

- 1 Un message structuré, pas un récit.** Les modèles hospitaliers existants supposent un interlocuteur médical, une ligne stable et un patient déjà évalué. En région isolée, la méthode CLAIR reprend les mêmes principes en les adaptant à votre contexte et à votre fiche SEP.
- 2 Préparez le message avant d'appeler.** Fiche SEP en main, position précise (coordonnées, repères, accès), état de la victime en une phrase, ce qui a été fait, ce que vous demandez. Un appel satellite coupe souvent après quelques secondes : l'essentiel se dit en premier.
- 3 Connaître vos moyens et leurs limites.** Cellulaire, téléphone satellite, messagerie satellite, radio, balise de détresse, messagers. Chacun a un délai, une portée et un mode d'échec. Le plan d'urgence dit lequel utiliser et à quel numéro.
- 4 Confirmez que le message a été compris.** Faites répéter les éléments critiques : lieu, nombre de victimes, gravité, moyen d'évacuation demandé, prochain contact. Convenez de l'heure du prochain appel et de ce qui se passe si vous ne rappelez pas.
- 5 Documentez ce que vous observez et ce que vous faites.** Heure de chaque appel, interlocuteur, contenu, décisions. Ce journal complète la fiche SEP et devient le fil du transfert aux services de secours.